



Resifriends
By Fátima Barbosa

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · EDIÇÃO APROFUNDADA

Fundamentos de Enfermagem

Semiotécnica, procedimentos e Processo de Enfermagem

Teoria clínica · densidade de prova · bizzus — Cargo: Enfermeiro /
PE

PESO MÉDIO · BASE DE TODA A ASSISTÊNCIA

Profa. Fátima Barbosa

Edição aprofundada · dados conferidos em fontes oficiais

Como usar esta edição aprofundada

Este não é um resumo. É material de estudo completo: cada tópico traz a teoria, o porquê clínico por trás dela e o modo como a banca transforma isso em questão.

Você encontrará quatro tipos de destaque ao longo do texto, cada um com uma função:

- ◆ **Aprofundamento clínico** — o raciocínio fisiopatológico que explica o dado.
- ◆ **Bizu Estratégico** — o macete que acelera o acerto.
- ◆ **Pegadinha Clássica** — o erro que a banca planta.
- ◆ **Como a banca cobra** — o formato real do enunciado.

O MAPA DESTE EIXO

- ◆ **Exame clínico e sinais vitais** — técnicas, valores e padrões alterados.
- ◆ **Medicação e cálculo** — vias, insulinas, gotejamento e diluição.
- ◆ **Procedimentos** — sondagens, oxigenoterapia, feridas.
- ◆ **Processo de Enfermagem** — NANDA, registro, prontuário, exames e precauções.

Sumário

1 Exame clínico e sinais vitais

As técnicas propedêuticas

Valores e alterações

Padrões respiratórios e pulsos

Temperatura e dor

2 Administração de medicamentos

Os certos

Vias e ângulos

Insulinas: tempo de ação

Preparo e diluição

3 Cálculo de medicação

Gotejamento

Regra de três

Diluição de fármacos

4 Sondagens vesical e gástrica

Vesical: alívio e demora

Gástrica e enteral

Cuidados e complicações

5 Oxigenoterapia

Baixo e alto fluxo

Dispositivos e FiO₂

Riscos

6 Feridas e curativos

Cicatrização

Tipos de ferida

Coberturas

7 Processo de Enfermagem e registros

As 5 etapas

NANDA/NIC/NOC

Registro e prontuário

8 Preparo para exames e precauções

Preparos

Precauções aplicadas

9 Síntese e bizus finais

Revisão rápida

1

Exame clínico e sinais vitais

A avaliação do paciente começa aqui. Cada dado alterado conta uma história clínica — e vira questão.

1 • Exame físico

O exame físico é a avaliação sistemática do corpo por meio de quatro técnicas propedêuticas. A ordem é fixa e a lógica é progressiva: parte-se do menos invasivo (olhar) ao mais invasivo (tocar e escutar profundamente).

TÉCNICA	O QUE AVALIA
Inspeção	Observação visual: cor da pele, simetria, forma, presença de lesões, expansibilidade torácica, padrão respiratório.
Palpação	Toque para avaliar textura, temperatura, umidade, turgor, dor, massas, frêmitos e pulsos.
Percussão	Golpes digitais que produzem sons (maciço, submaciço, timpânico, claro pulmonar) e delimitam órgãos.
Ausculta	Escuta com estetoscópio de sons pulmonares, cardíacos, ruídos hidroaéreos e sopros.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que a ordem importa clinicamente: a percussão e a palpação **mobilizam** estruturas e alteram os ruídos intestinais. Por isso, no **exame do abdome**, inverte-se a ordem — ausculta-se *antes* de tocar, para registrar os ruídos hidroaéreos no seu estado natural. Nos demais segmentos, mantém-se inspeção → palpação → percussão → ausculta.

PEGADINHA CLÁSSICA

Sequência do abdome: inspeção → **ausculta** → percussão → palpação. A banca apresenta a ordem “normal” (com palpação antes da ausculta) como se valesse para o abdome — é erro. Só o abdome inverte.

COMO A BANCA COBRA

“Durante o exame físico do abdome, a sequência correta das técnicas propedêuticas a ser adotada pelo enfermeiro é...”

A resposta é sempre inspeção, ausculta, percussão e palpação. O enunciado costuma vir com a palavra **“abdome”** destacada justamente para testar se você sabe da exceção.

1 · Sinais vitais e seus valores

Os sinais vitais — temperatura, pulso, respiração, pressão arterial e, agregada, a saturação de oxigênio e a dor (o “quinto” e o “sexto” sinal) — são a base da avaliação e da detecção precoce de deterioração clínica.

SINAL VITAL	REFERÊNCIA NO ADULTO
Frequência cardíaca	60 a 100 bpm no adulto. < 60: bradicardia; > 100: taquicardia.
Frequência respiratória	12 a 20 irpm. < 12: bradipneia; > 20: taquipneia.
Pressão arterial	Ótima ~120/80 mmHg; a partir de 140/90 considera-se hipertensão (aferição de consultório).
Temperatura axilar	36 a 37,3 °C. Febre a partir de ~37,8 °C; hipotermia < 35 °C.
Saturação de O ₂	≥ 95% em ar ambiente.

◆ Padrões respiratórios alterados

A banca adora associar um padrão respiratório à sua doença típica. Guarde a tríade mais cobrada:

PADRÃO	CARACTERÍSTICA E ASSOCIAÇÃO
Eupneia	Respiração normal, ritmada (12–20 irpm).
Taquipneia / Bradipneia	FR acima de 20 / abaixo de 12.
Cheyne-Stokes	Ciclos de amplitude crescente e decrescente alternados com apneia. Associada a insuficiência cardíaca, AVC e lesões neurológicas.
Kussmaul	Respiração ampla, rápida, profunda e ruidosa. Marca da cetoacidose diabética (acidose metabólica).
Biot	Respiração irregular e atáxica, com apneias variáveis. Indica comprometimento neurológico grave (ex.: meningite, lesão de tronco).

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A lógica fisiopatológica: na **cetoacidose diabética**, o organismo acumula ácido e tenta eliminá-lo “soprando” CO₂ — daí a respiração de **Kussmaul**, profunda e rápida, uma compensação respiratória da acidose metabólica. Já a **Cheyne-Stokes** reflete atraso circulatório e disfunção do centro respiratório, típica da insuficiência cardíaca e de lesões cerebrais.

COMO A BANCA COBRA

“Paciente diabético dá entrada com hálito cetônico e respiração ampla, profunda e ruidosa. Esse padrão respiratório é denominado...”

Kussmaul. O enunciado entrega as pistas (diabético + hálito cetônico + profunda) — reconhecer a associação é a questão.

◆ Pulso e temperatura

O pulso é avaliado em frequência, ritmo, amplitude e simetria. Termos cobrados:

- ◆ **Taquisfigmia / bradisfigmia** — pulso acelerado / lento.
- ◆ **Pulso filiforme** — fino e fraco, sinal de baixa perfusão (choque).
- ◆ **Pulso paradoxal** — queda da amplitude na inspiração (tamponamento).

ESTADO TÉRMICO	FAIXA
Normotermia	36 a 37,3 °C.
Febril / Febre	37,8 a 38,9 °C.
Pirexia / hipertermia	≥ 39 °C.
Hipotermia	< 35 °C.

◆ Dor — o 5º sinal vital

A dor deve ser avaliada e registrada sistematicamente. A escala mais usada é a **Escala Visual Analógica (EVA)**, de 0 (ausência de dor) a 10 (pior dor imaginável). Existem escalas específicas para quem não verbaliza (faces, FLACC em crianças).

BIZU ESTRATÉGICO

Guarde os limites-âncora: FC 60–100, FR 12–20, $\text{SatO}_2 \geq 95\%$, febre $\geq 37,8^\circ\text{C}$. E as três respirações-chave: Kussmaul = diabético; Cheyne-Stokes = cardíaco/neuro; Biot = neurológico grave.

2

Administração de medicamentos

Segurança na medicação é meta internacional. Aqui, vias, ângulos e o tempo de ação das insulinas.

2 · Os certos e a segurança

A administração segura evoluiu dos 5 certos clássicos para 9 ou mais, alinhados à Meta 3 de segurança do paciente (medicamentos). Conhecê-los na ordem é cobrança frequente.

OS 9 CERTOS DA MEDICAÇÃO

- ◆ 1) Paciente certo · 2) Medicamento certo · 3) Dose certa.
- ◆ 4) Via certa · 5) Hora certa · 6) Registro certo.
- ◆ 7) Orientação certa · 8) Forma/apresentação certa · 9) Resposta (monitorização) certa.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O **registro certo** não é burocracia: uma dose administrada e não registrada pode ser *repetida* por outro profissional, gerando superdose. Por isso o registro integra a segurança do processo, não é etapa posterior a ele.

2 · Vias e ângulos de injeção

VIA	ÂNGULO, USO E ABSORÇÃO
Intradérmica (ID)	15°. Volume ínfimo (0,1 mL). Absorção lenta. Ex.: BCG, PPD, testes de sensibilidade.
Subcutânea (SC)	45° (ou 90° com prega cutânea). Ex.: insulina, heparina, enoxaparina. Rodízio de locais obrigatório.
Intramuscular (IM)	90°. Volumes maiores. Locais: ventroglúteo (preferencial), vasto lateral da coxa, deltoide.
Endovenosa (EV)	Direto na corrente sanguínea. Absorção imediata e total (biodisponibilidade 100%).

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o **ventroglúteo** é hoje o local IM preferencial: é livre de grandes vasos e nervos (evita o nervo isquiático, risco do dorsoglúteo), comporta bom volume e tem menos tecido adiposo. A segurança anatômica é o motivo — não é preferência arbitrária.

PEGADINHA CLÁSSICA

Pegadinhas de via: (1) trocar o ângulo (ID 15°, SC 45°, IM 90°); (2) dizer que insulina e heparina são IM — são **SC**; (3) apontar o dorsoglúteo como “mais seguro” — o atual preferencial é o **ventroglúteo**.

2 · Insulinas: o tempo de ação

O tema mais clínico da medicação. A insulina é subcutânea (a Regular também pode ser EV em emergência) e cada tipo tem um perfil de início, pico e duração — o que define *quando* aplicar e *quando* vigiar hipoglicemia.

TIPO	INÍCIO / PICO / DURAÇÃO
Ultrarrápida (Lispro, Asparte, Glulisina)	Início 5–15 min; pico 1–2 h; duração 4–6 h. Aplicar junto à refeição.
Rápida / Regular	Início 30–60 min; pico 2–4 h; duração 5–8 h. Aplicar ~30 min antes da refeição. É a insulina de aspecto límpido.
Intermediária (NPH)	Início 1–3 h; pico 4–8 h; duração até 18 h. Aspecto turvo (suspensão) — homogeneizar antes.
Prolongada (Glargina, Detemir, Degludeca)	Início 1–2 h; sem pico pronunciado; duração 24 h ou mais. Ação basal.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O **pico** é o momento de maior risco de **hipoglicemia**. Por isso a NPH, com pico em 4–8 h, exige atenção redobrada nesse intervalo. Já as prolongadas, *sem pico*, oferecem menor risco de hipoglicemia — daí a preferência para cobertura basal estável.

BIZU ESTRATÉGICO

Ao misturar NPH + Regular na mesma seringa, aspira-se primeiro a **Regular** (límpida) e depois a NPH (turva): “primeiro a clara, depois a turva”. Assim evita-se contaminar o frasco de Regular com a NPH. Cai muito.

COMO A BANCA COBRA

“Ao preparar em uma mesma seringa insulina NPH e insulina Regular, o enfermeiro deve aspirar primeiro a insulina...”

Regular (a límpida/clara). A justificativa cobrada é evitar que a suspensão turva da NPH contamine o frasco da Regular.

3

Cálculo de medicação

O tema que nunca falta. Domine as constantes e três fórmulas resolvem quase tudo.

3 · Gotejamento e diluição

Tudo parte de duas constantes universais do equipo:

AS CONSTANTES QUE VOCÊ PRECISA DECORAR

- ◆ 1 mL = **20 gotas** (macrogotas) = **60 microgotas**.
- ◆ Logo, **1 gota = 3 microgotas**.
- ◆ Numericamente: **microgotas/min = mL/hora**.

SITUAÇÃO	FÓRMULA
Macrogotas (horas)	$\text{n}^\circ \text{ gotas/min} = \text{volume (mL)} \div (\text{tempo em horas} \times 3)$.
Microgotas (horas)	$\text{n}^\circ \text{ microgotas/min} = \text{volume (mL)} \div \text{tempo em horas}$.
Macrogotas (minutos)	$\text{n}^\circ \text{ gotas/min} = (\text{volume} \times 20) \div \text{tempo em minutos}$.
Microgotas (minutos)	$\text{n}^\circ \text{ microgotas/min} = (\text{volume} \times 60) \div \text{tempo em minutos}$.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o gotejamento importa clinicamente: infundir **rápido demais** pode sobrecarregar a volemia e precipitar **edema agudo de pulmão** em cardiopatas e idosos; **lento demais** compromete a ação de antibióticos tempo-dependentes. O cálculo é segurança, não formalidade.

COMO A BANCA COBRA

“Foram prescritos 500 mL de soro fisiológico para infundir em 6 horas, em equipo de macrogotas. O gotejamento aproximado é de...”

$500 \div (6 \times 3) = 500 \div 18 \approx \mathbf{28 \text{ gotas/min}}$. O padrão de enunciado dá volume, tempo e tipo de equipo; identificar os três dados e aplicar a fórmula certa resolve.

◆ Regra de três para dose e diluição

Quando a prescrição pede uma dose contida num frasco (ex.: administrar 250 mg de um frasco de 500 mg diluído em 10 mL), usa-se regra de três para achar o volume:

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

500 mg — 10 mL; 250 mg — x. Logo $x = (250 \times 10) \div 500 = 5 \text{ mL}$. Se esse volume for adicionado a um soro para correr por gotejamento, soma-se ao volume total antes de calcular as gotas.

4

Sondagens

Vesical e gástrica. Indicação, calibre, técnica e a responsabilidade legal.

4 · Cateterismo vesical

TIPO	CARACTERÍSTICA E INDICAÇÃO
De alívio (intermitente)	Esvaziamento pontual; cateter sem balão; retirado ao fim da drenagem. Ex.: retenção urinária, medida de urina residual, coleta asséptica.
De demora	Permanência prolongada; cateter de Foley (duplo lúmen) com balão insuflado; sistema coletor fechado.

ITEM	REFERÊNCIA
Calibre adulto	Foley 12 a 16 Fr; homens frequentemente 16–18 Fr.
Calibre criança	6 a 10 Fr.
Técnica	Estéril/asséptica. Coletor sempre abaixo do nível da bexiga (evita refluxo).

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o coletor fica **abaixo da bexiga**: o refluxo de urina já drenada de volta à bexiga é uma das principais portas para **infecção do trato urinário associada a cateter** (ITU-AC). Manter o sistema fechado e o fluxo por gravidade é medida central de prevenção.

PEGADINHA CLÁSSICA

Ponto de ouro que cruza com Ética: a **execução** da sondagem vesical é **privativa do enfermeiro** (Resolução COFEN 450/2013, alterada pela 0680/2021). O técnico auxilia, mas não passa a sonda. Atribuir a passagem ao técnico é erro.

4 · Sondagem gástrica e enteral

SONDA	DESTINO E USO
Nasogástrica (SNG)	Ponta no estômago. Descompressão/drenagem ou alimentação de curto prazo. Calibre maior.
Nasoenteral (SNE)	Ponta no intestino (duodeno/jejuno). Nutrição enteral; calibre fino, com fio guia; posição pós-pilórica.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A medida de inserção da SNG usa a referência **NEX**: do **N**ariz à **E**orelha (lóbulo) e ao apêndice **X**ifoide. Essa medição estima o comprimento até o estômago antes da introdução.

BIZU ESTRATÉGICO

Confirmação de posicionamento da sonda enteral: o padrão-ouro é a **radiografia** antes da primeira dieta. A ausculta epigástrica (injetar ar e escutar) *isolada* não é confiável e caiu em desuso como confirmação única. A banca cobra a radiografia.

5

Oxigenoterapia

Ofertar oxigênio com segurança. Baixo × alto fluxo e a FiO_2 de cada dispositivo.

5 · Dispositivos de oxigenoterapia

Os sistemas dividem-se em **baixo fluxo** (a FiO_2 varia com o padrão respiratório do paciente) e **alto fluxo** (FiO_2 controlada).

DISPOSITIVO	FLUXO E FiO_2
Cânula/cateter nasal	Baixo fluxo, 1–5 L/min. FiO_2 ~24–44%. Permite falar e comer; conforto.
Máscara simples	5–10 L/min. FiO_2 ~40–60%. Fluxo mínimo de 5 L/min para lavar o CO_2 exalado.
Máscara de Venturi	Alto fluxo com FiO_2 precisa e controlada por válvulas coloridas. Ideal quando a exatidão importa.
Máscara com reservatório (não reinalante)	10–15 L/min. FiO_2 alta (~90–100%). Para hipoxemia grave.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que a **Venturi** é preferida no **DPOC**: nesses pacientes, ofertar O_2 em excesso pode reduzir o estímulo respiratório e reter CO_2 . A Venturi entrega uma **FiO_2 exata e titulável**, permitindo corrigir a hipoxemia sem excesso. É o raciocínio por trás da recomendação.

PEGADINHA CLÁSSICA

Trocas cobradas: cateter nasal descrito como “alto fluxo/ FiO_2 precisa” (é baixo fluxo, FiO_2 variável); e Venturi apresentada como imprecisa (é justamente a **mais precisa**). Atenção também ao ressecamento de mucosa em fluxos altos — indica umidificação.

6

Feridas e curativos

A cobertura certa segue a ferida. Fases da cicatrização e escolha do curativo.

6 · Cicatrização e tipos de ferida

A cicatrização ocorre em fases sobrepostas: **inflamatória** (hemostasia e limpeza), **proliferativa** (tecido de granulação, angiogênese) e **remodelação/maturação** (reorganização do colágeno).

TIPO DE FECHAMENTO	CARACTERÍSTICA
Primária	Bordas aproximadas (sutura). Cicatrização rápida, mínima perda tecidual.
Secundária	Bordas afastadas, cicatriza por granulação (ex.: úlceras, feridas infectadas).
Terciária	Fechamento tardio após controle de infecção/contaminação.

◆ Coberturas — associar ao exsudato

COBERTURA	INDICAÇÃO
Hidrocoloide	Exsudato leve a moderado; mantém meio úmido; favorece granulação.
Alginate de cálcio	Feridas muito exsudativas; altíssima absorção; ação hemostática.
Hidrogel	Feridas secas ou com necrose; hidrata e promove desbridamento autolítico.
Carvão ativado (com prata)	Feridas infectadas e com odor; controla odor e carga bacteriana.
Ácidos graxos essenciais (AGE)	Hidratação, proteção e estímulo à granulação; prevenção.
Espuma / hidrofibra	Exsudato moderado a intenso; absorção e conforto.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

O princípio moderno é o **meio úmido**: ao contrário da crença antiga de “deixar secar”, a umidade fisiológica acelera a migração celular e a granulação. Por isso as coberturas buscam *equilibrar* a umidade — hidratar o que está seco, absorver o que está encharcado.

BIZU ESTRATÉGICO

Regra de três da cobertura: **muito exsudato → alginato; seca/necrose → hidrogel; odor/infecção → carvão ativado**. Casar a cobertura com a característica da ferida resolve a maioria das questões.

COMO A BANCA COBRA

“Ferida com grande quantidade de exsudato e sangramento discreto. A cobertura mais indicada é...”

Alginato de cálcio — alta absorção e ação hemostática. O enunciado descreve a **característica** da ferida (muito exsudato) esperando que você associe à cobertura.

7

Processo de Enfermagem

O raciocínio clínico sistematizado. NANDA, registro e prontuário eletrônico.

7 · As cinco etapas

O Processo de Enfermagem é regido pela **Resolução COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024**, que substituiu a antiga 358/2009. Organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas.

Resolução COFEN nº 736/2024 (substitui a 358/2009)

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A atualização que derruba material antigo. A Resolução 736/2024 **retirou o termo “SAE”** (considerado abstrato e confuso nas pesquisas) e renomeou a primeira etapa: o que era “coleta de dados / histórico de enfermagem” passou a ser **Avaliação de Enfermagem**. O PE deixa de ser formulário e passa a ser explicitamente **método de julgamento clínico**.

ETAPA	O QUE É
1. Avaliação de Enfermagem	Coleta de dados subjetivos (entrevista) e objetivos (exame físico), inicial e contínua. (Antiga “coleta de dados”.)
2. Diagnóstico de Enfermagem	Julgamento clínico: identifica problemas, vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos. Usa a taxonomia NANDA-I. Privativo do enfermeiro .
3. Planejamento de Enfermagem	Plano compartilhado com a pessoa e a equipe; resultados esperados e prescrição de enfermagem.
4. Implementação	Execução das ações, conforme a competência técnica de cada profissional.
5. Avaliação de Resultados (evolução)	Verificação dos resultados e ajuste do plano.

◆ NANDA, NIC e NOC

- ◆ **NANDA-I** — taxonomia dos *diagnósticos* de enfermagem.
- ◆ **NIC** — classificação das *intervenções*.
- ◆ **NOC** — classificação dos *resultados*.

BIZU ESTRATÉGICO

Mnemônico atualizado: “**Avaliei, Diagnostiquei, Planejei, Implementei, Avaliei o resultado**” — a **avaliação abre e fecha o ciclo**. Continuam **privativos do enfermeiro o diagnóstico e a prescrição de enfermagem**. Um diagnóstico NANDA tem **título + fatores relacionados + características definidoras**.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Anatomia do diagnóstico NANDA: **título** (ex.: “risco de queda”), **fatores relacionados** (as causas) e **características definidoras** (os sinais observados). Diagnósticos *de risco* **não têm** características definidoras — trazem *fatores de risco*, porque o problema ainda não se instalou.

PEGADINHA CLÁSSICA

Se o material cita “**SAE**” e “**coleta de dados**” pela Resolução 358/2009, está desatualizado — a vigente é a **736/2024**. Mas atenção ao comando: se a questão *citar* a 358, siga a redação dela; se disser “**norma vigente**”, é a 736. E o diagnóstico **nunca é do técnico**.

7 · Registro e prontuário

A anotação de enfermagem é **documento legal** e prova da assistência prestada. Deve ser clara, objetiva, completa, legível, sem rasuras, com data, hora, assinatura e carimbo (COREN).

PEGADINHA CLÁSSICA

Regras que caem: **nunca rasurar** (o erro se corrige conforme a norma, sem apagar/rasurar); não deixar linhas ou espaços em branco entre anotações; registrar apenas o que foi realizado; e o registro é de **responsabilidade individual e intransferível**. No prontuário eletrônico, cada profissional usa login próprio e **não compartilha senha** — o acesso é rastreável e pessoal.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o prontuário eletrônico exige senha individual: cada registro fica vinculado a quem o fez (rastreabilidade). Compartilhar senha quebra a autoria legal do registro e pode responsabilizar indevidamente outro profissional — é falha ética e de segurança.

8

Exames e precauções

Onde fundamentos encontra a segurança do paciente.

8 · Preparo para exames

- ◆ **Jejum:** respeitar o tempo por exame (glicemia de jejum, perfil lipídico).
- ◆ **Urocultura:** jato médio após higiene íntima, frasco estéril; ideal a primeira urina da manhã.
- ◆ **Hemocultura:** antisepsia rigorosa; colher, preferencialmente, antes do início do antibiótico e em picos febris.
- ◆ **Consentimento e orientação:** explicar o procedimento e respeitar o direito de recusa do paciente.

8 · Precauções aplicadas ao procedimento

PRECAUÇÃO	MEDIDA E EXEMPLOS
Padrão	Todos os pacientes: higiene das mãos e EPI conforme risco de exposição a fluidos.
Contato	Luvas + avental; quarto privativo/coorte. Ex.: multirresistentes, <i>C. difficile</i> , escabiose.
Gotículas	Máscara cirúrgica. Ex.: meningite, coqueluche, caxumba, influenza.
Aerossóis	Máscara N95/PFF2 + pressão negativa. Ex.: tuberculose, sarampo, varicela.

BIZU ESTRATÉGICO

Antes de qualquer procedimento invasivo (sondagem, punção, curativo): **higiene das mãos e técnica asséptica**. Os 5 momentos da higiene das mãos e a precaução correta são cobrados dentro de casos de fundamentos, não só em controle de infecção.

9

Síntese

A página de revisão que reúne os números e as trocas que a prova cobra.

9 · Revisão rápida do eixo

EXAME, SINAIS E MEDICAÇÃO

- ◆ Abdome: inspeção → **ausculta** → percussão → palpação.
- ◆ FC 60–100; FR 12–20; SatO₂ ≥ 95%; febre ≥ 37,8 °C.
- ◆ Kussmaul = diabético; Cheyne-Stokes = cardíaco/neuro; Biot = neuro grave.
- ◆ Ângulos: ID 15°, SC 45°, IM 90°. IM preferencial: ventroglúteo.

INSULINA, CÁLCULO E PROCEDIMENTOS

- ◆ Regular (límpida): 30–60 min / pico 2–4 h. NPH (turva): pico 4–8 h.
- ◆ Misturar: aspirar primeiro a **Regular** (clara antes da turva).
- ◆ 1 mL = 20 gtt = 60 microgtt; microgotas/min = mL/hora.
- ◆ Sondagem vesical: privativa do enfermeiro; SNE confirmada por radiografia.

OXIGENOTERAPIA, FERIDAS E PROCESSO

- ◆ Venturi = FiO₂ precisa (DPOC); cateter nasal = baixo fluxo.
- ◆ Muito exsudato → alginato; seca/necrose → hidrogel; odor/infecção → carvão.
- ◆ **PE (Res. 736/2024)**: substituiu a 358/2009 e **retirou o termo SAE**. 1ª etapa = **Avaliação de Enfermagem**.
- ◆ Etapas: Avaliação → Diagnóstico → Planejamento → Implementação → Avaliação de resultados. Diagnóstico e prescrição **privativos**.
- ◆ Registro: sem rasura, responsabilidade individual, senha não se compartilha.

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas campeãs de Fundamentos: (1) ordem do exame do abdome; (2) ângulo de injeção; (3) ordem de aspiração das insulinas; (4) sondagem vesical dada ao técnico; (5) rasura no registro. Dominar essas cinco blinda grande parte do eixo.

“Fundamentos é onde a enfermagem começa. Quem entende o porquê, não esquece o quê — e reconhece a pegadinha.”

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · FUNDAMENTOS (APROFUNDADO)

Procedimentos, cálculos, perfis de insulina e resoluções conferidos em fontes oficiais (COFEN — incluindo a Resolução nº 736/2024, ANVISA, Ministério da Saúde e literatura de referência). Confirme protocolos e resoluções vigentes antes da prova.